

EXAMEN DE L'ABDOMEN

- Se laver les mains (former le robinet avec le papier).
- Demander au patient de soulever son pull

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Bon éclairage
- Patient détendu
- Mise en nu complète de l'abdomen : il faut pouvoir voir les régions inguinales
- Régions inguinales visibles
- Mains chaudes et ongles courts
 - ⚠ La vessie doit être vide
 - ⚠ Donner l'impression d'une totale disponibilité

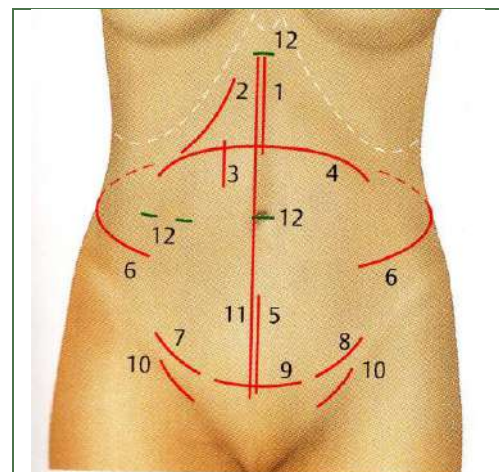
POSITIONNER LE PATIENT

- Doit être couché confortablement, sur le dos, avec un coussin sous la tête (sous les genoux).
- Les bras le long du corps
- Expliquer (prévenir) !
- Garantir l'intimité

OBSERVER

POINTS PRINCIPAUX À OBSERVER

1. Est-ce que le patient a mal ? Si une personne à mal au ventre, le patient à des jambes pliées et les mains sur le ventre.
2. Comment est-ce que le patient respire ? S'il a mal, il respire avec les poumons. Si n'a pas mal, il respire avec le ventre.
3. La peau



- 2 : rebord costal
 4. foie et pancréas
 6 : rétro-péritoine
 7 : appendice
 9 : césarienne ou hystérectomie
 10 : vaisseaux

POINTS À OBSERVER

- Le visage du patient :
 - Malaise
 - Douleur
 - Respiration
- La peau :
 - Cicatrices : demander s'il a été opéré
 - Vergetures
 - Veines dilatées : hypertension portal : obstruction portale : cirrhose
 - Lésions cutanées
 - Autre élément : bronzé ? péristaltisme ?
- L'ombilic :
 - Localisation : est-il au milieu ?

- Aspect : il y a-t-il une voussure ?
 - Couleur
 - Hernie ?
- Allure de l'abdomen :
 - Plat, arrondi
 - Protubérant
 - « Scaphoïde »
 - Voussure localisée
 - Symétrie
- Mouvements :
 - Respiratoires : comment est-ce qu'il respire ? S'il va mal, il respire avec les poumons. S'il est en bon état, il respire avec le ventre.
 - Péristaltiques
 - Pulsatiles

AUSCULTATION

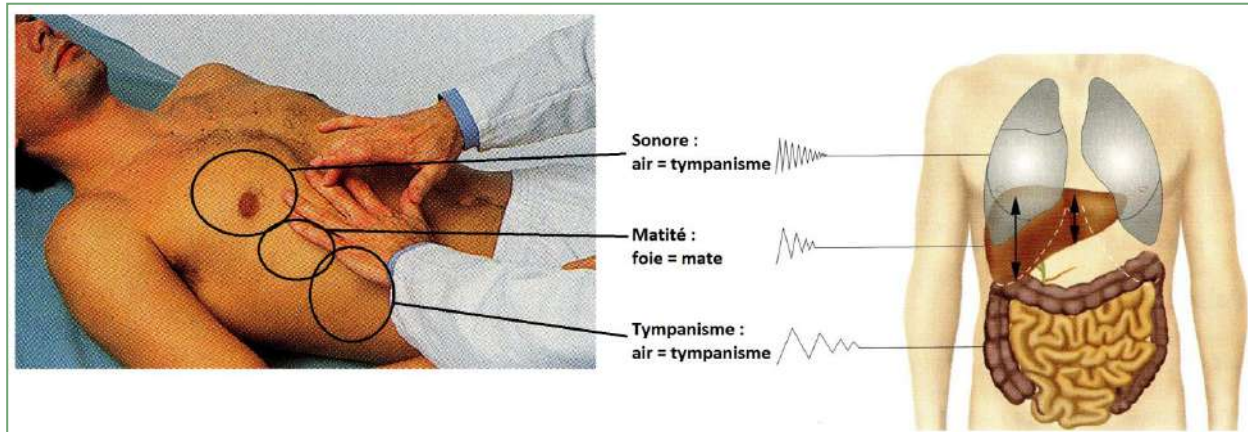
- **Avant d'examiner, demander au patient d'indiquer la (les) région(s) douloureuse(s).**
- Prévenir
- Ausculter (il faut utiliser la membrane du stéthoscope) : on pose dessus.
 - ⚠ L'auscultation doit se réaliser avant de palper sinon on risque de stimuler le péristaltisme.
 - ⚠ Il ne faut pas ausculter l'endroit où il a mal.
- Ecouter les 4 quadrants :

On peut provoquer de petits bruits et ensuite écouter. : On appuie avec le stéthoscope puis, on écoute. On ausculte avant de palper.

 - Bruits :
 - Qualité (tonalité) : aigue (toang), iléus ; gargouillement (nourriture)
 - Quantité (fréquence) : absence de bruits (iléus), augmentée (hyperpéristaltisme)
 - Normalement : cliquetis, gargouilles, fréquence 5-34/min
 - Souffle vasculaire : aorte, artère iliaque : écouter l'aorte, au centre avec la cloche.

PERCUSSION

- Prévenir :
 - Informer
 - Se désinfecter les mains et les réchauffer
 - Demander au patient lorsqu'il a mal.
- Percussion de chaque quadrant
- Délimiter le foie :
 - Commencer la percussion au niveau des poumons et descendre le long de la ligne médio-claviculaire, jusqu'à entendre le tympanisme de l'abdomen.
 - Il faut déterminer la taille du foie au niveau de la ligne médio-claviculaire.



PALPATION

⚠ Il ne faut jamais palper où le patient ressent de la douleur. Il faut terminer où le patient a mal.

- Prévenir

- **En cas de résistance :**

- Tenter de détendre le patient
 - Relâchement du muscle grand droit en expiration
 - Demander au patient de respirer par la bouche, la mâchoire tombante.

- Palpation superficielle

- Application :

- Placer superficiellement la main avec les 5 doigts sur les différents cadrants et observer la réaction du patient
 - Palper également la vessie



- But :

- Aide à lever la résistance musculaire
 - Identifie les structures superficielles et d'éventuelles masses .
 - Sert à identifier les points douloureux.

- Palpation profonde

- Application :

- Exploration des 4 quadrants avec la pulpe des doigts : superposer les deux mains pour mieux contrôler la force

- Il faut terminer la palpation sur l'endroit où le patient a mal.

L'examineur doit chercher les détentes. Il appuie profondément,

demande au patient s'il a mal. Puis l'examineur relâche et demande au patient s'il a mal. Ce permet d'identifier une

détente (le patient souffre davantage lorsque l'examineur relâche). Celle-ci

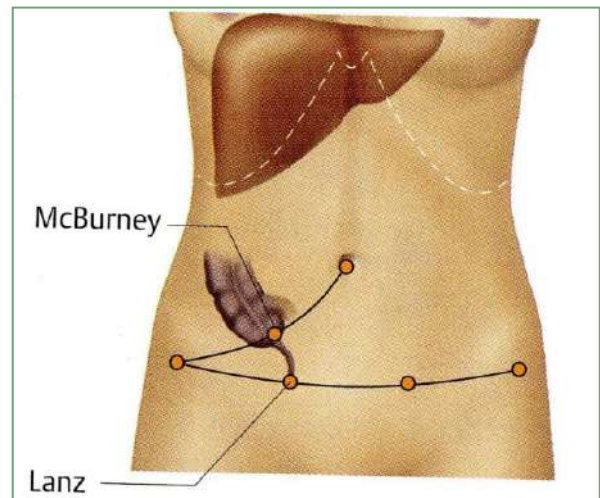


indique une irritation du péritoine, une péritonite. Cf. : Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme

- Pour toute masse, préciser:
 - Localisation
 - Forme
 - Taille
 - Consistance
 - Sensibilité
 - Mobilité

Identifier toutes les masses et noter leur emplacement, la taille, la forme, la consistance, la tendresse, pulsations, et leur déplacement lors la respiration ou avec la main d'instruction. Corréler ces résultats (palpables) avec la percussion.

- Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme :
 - Palpation légère avec un doigt pour la localiser exactement : on cherche.
 - Rechercher une douleur à la décompression brusque (détente) :
 - Appuyer profondément et lâcher sans prévenir en regardant le visage du patient.
 - Refaire le même mouvement en demandant, cette fois-ci, au patient d'indiquer une éventuelle douleur (lorsque l'examineur appuie ou lorsqu'il détend).
 - Demander au patient où il ressent la douleur (où l'examineur appuie ou autre part ?).
 - Le péritoine est infecté ou irrité lorsque le patient ressent plus de douleur après décompression. De plus, lorsque la douleur est étendue (géographiquement) (détente croisée), la péritonite est plus grave.
- Examen de McBurney et le signe du Psoas :
 - L'appendice se trouve au niveau du point de McBurney : localisation :
 - Crête iliaque antéro-supérieure droite
 - On relie la crête à l'ombilic
 - Au deux tiers (~milieu) de cette ligne se trouve le point de McBurney
 - Si l'appendice est enflammé, le patient souffre lorsque l'examineur appuie sur le point de McBurney
 - Mais 30%, des appendices sont rétro-caecale. L'appendice est dans ce cas couché sur le psoas.
 - Identifier une appendicite :
 - Demander au patient de fléchir la cuisse
 - L'examineur appuie vers le bas et le patient doit maintenir la jambe fléchit (le psoas est sous tension).
 - Si le patient a une appendicite, il devrait avoir mal.



- Toute palpation doit être décrite :

Description	
• Localisation :	quadrant, région
• Taille:	cm, comparative
• Surface:	lisse, nodulaire
• Contour :	concis, diffus
• Consistance:	dur, mou, fluctuant
• Mobilité:	oui-non
• Douloureux:	oui-non
• Pulsation:	oui-non

LE FOIE

- Estimer :
 - Taille : grâce à la percussion
 - Forme
 - Consistance
 - Sensibilité

- (Percussion)

Un épanchement pleural peut augmenter faussement l'estimation de la taille du foie. Le gaz dans le côlon peut produire tympanite dans le quadrant droit et ainsi diminuer faussement l'estimation de la taille du foie.

- Palpation :

- On cherche le bord du foie :
 - L'examineur palpe vers le rebord costal avec sa main droite
 - Autre possibilité : bi-manuellement :
Il place sa main gauche derrière le patient, parallèlement aux côtes droites 11 et 12. Il rappelle au patient qu'il peut se détendre sur la main de l'examineur si nécessaire. L'examineur place sa main droite sur le foie. L'examineur soulève avec la main gauche ce qui facilite la perception du foie par la main droite. L'examineur appuie avec sa main droite doucement et vers le haut.

Palpation du foie

main gauche: derrière le dos du malade, parallèlement à la 11ème et 12ème côte
main droite: sur le côté droit de l'abdomen, en dehors du muscle grand droit

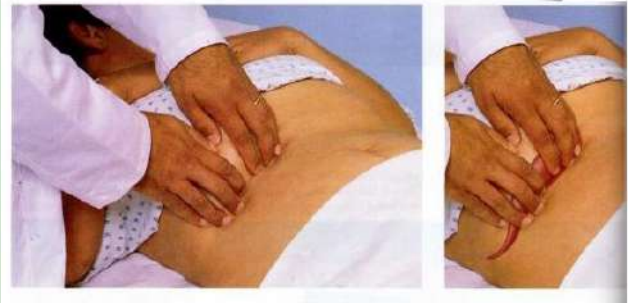
demander au patient d'inspirer profondément



- *L'examineur demande au patient de prendre une profonde respiration et il essaie de sentir le bord du foie (dès qu'il le sent, il est conseillé d'alléger la pression et de palper légèrement).*
- *S'il ne peut pas le sentir, l'examineur doit déplacer sa main près du rebord costal et réessayez.*
- **Signe de Murphy :** palpation de la vésicule biliaire : *L'examineur place ses mains au niveau du rebord costal droit. Le patient inspire (il pousse le foie vers le bas). Si la vésicule est enflammée, elle touche la main de l'examineur et le patient ressent de la douleur. Permet de diagnostiquer une cholecystite.*
 - ⚠ Il est important que le patient ait la tête relâchée (pas de contraction de l'abdomen) et les mains le long du corps.
 - ⚠ Normalement un foie sain n'est pas palpable.
- **Technique de crochet :**
 - *Même technique mais les mains sont placées sur le rebord costal depuis les poumons. Elle est utile surtout lorsque le patient est obèse.*
 - *L'examineur se tient à droite de la poitrine du patient. Il place ses deux mains, côte à côte, sur la droite de l'abdomen en dessous de la frontière de la matité du foie. Il appuie avec ses doigts vers le haut et vers le rebord costal.*
 - *Le patient de prendre une profonde respiration. Le bord du foie ci-dessous est palpable avec les bouts de doigts des deux mains.*

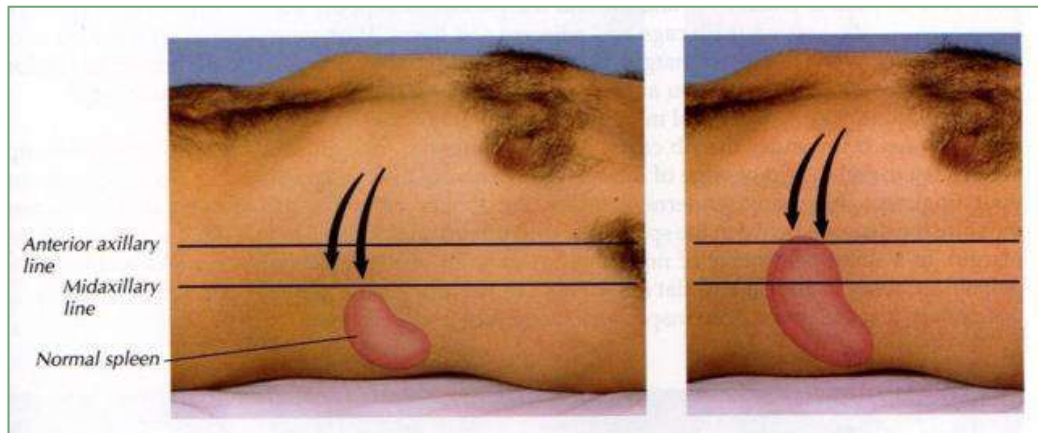
« Technique du crochet »

- surtout pour les patients obèses
- les deux mains: côté droite de l'abdomen, au-dessous de la zone de matité hépatique. Enfoncer les doigts sous le rebord costal. Patient en inspiration profonde



LA RATE

- **Percussion :**
 - Percuter la rate dans le sens des flèches :
 - *L'examineur percute la paroi thoracique antérieure inférieure gauche entre la résonance du poumon et au-dessus du rebord costal, à savoir l'espace de Traube.*
 - Lorsque la taille de la rate est normale, cette percussion latérale reste généralement tympanique. Si le tympanisme est important, surtout latéralement, splénomégalie est peu probable. La grisaille pourrait indiquer une splénomégalie et les fluides ou solides dans l'estomac ou du côlon peuvent causer une matité.
 - Lorsque la rate grossit, elle se développe en avant, en bas et en dedans.



- Palpation :
 - L'examineur passe sa main gauche autour du patient pour soutenir et appuyer vers l'avant de la cage thoracique inférieure gauche et les tissus mous adjacents. Il place sa main droite au-dessous du rebord costal gauche et il appuie en direction.
 - Il est conseillé de commencer la palpation suffisamment bas pour pouvoir sentir la rate sans en être empêché par la cage thoracique.
 - L'examineur demande au patient de prendre une profonde inspiration. Il essaie de sentir la pointe ou le bord de la rate comme avec le bout de ses doigts.
 - Demander au patient s'il ressent une douleur.
 - La rate n'est jamais palpable que lorsqu'elle est immense.

Palpation de la rate

main gauche: dessus et autour du patient pour soulever et pousser vers l'avant la base thoracique gauche
main droite: sous le rebord costal gauche, appuyer en direction de la rate
 demander au patient d'inspirer profondément



LES REINS

- Percussion :
 - L'examineur demande au patient de s'asseoir.
 - Le poignet fermé, l'examineur percute, avec la surface ulnaire du poing, les reins au niveau de l'angle costo-vertébral.
 - L'examineur doit utiliser assez de force pour provoquer bruit perceptible mais indolore chez une personne normale.
 - Un patient souffrant d'une pyélonéphrite (infection du bassinet) aura mal.



- Palpation

- Palpation du rein droit :

- L'examineur se déplace sur le côté droit du patient.
 - Il place sa main gauche derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main droite doucement dans le quadrant supérieur droit, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main gauche en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main droite fermement et profondément dans le quadrant supérieur droit, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.
 - L'examineur demande ensuite au patient d'expirer et puis d'arrêter de respirer brièvement. Il relâche doucement la pression de sa main droite, en sentant le rein glisser dans sa position expiratoire.
 - Si le rein est palpable, il faut décrire sa taille, contour, et toute tendresse.
 - Un rein normal droit peut être palpable, surtout dans les femmes minces bien détendues. Parfois, le foie peut recouvrir le rein droit et empêche la palpation.

Rein droit

Main gauche: sous le patient juste au dessous et le long de la 12^e côte, l'extrémité des doigts atteignant l'angle costovertébral, soulever pour déplacer le rein en avant

Main droite: dans le quadrant supérieur droit, le long du bord externe du grand droit

Rein gauche

soulever le dos du patient avec la main droite et enfoncez la main gauche dans le quadrant supérieur gauche



- Palpation du rein gauche :

- L'examineur se déplace sur le côté gauche du patient.
 - Il place sa main droite derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main droite doucement dans le quadrant supérieur gauche, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main droite en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main gauche fermement et profondément dans le quadrant supérieur gauche, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.
 - L'examineur demande ensuite au patient d'expirer et puis d'arrêter de respirer brièvement. Il relâche doucement la pression de sa main gauche, en sentant le rein glisser dans sa position expiratoire.
 - Si le rein est palpable, il faut décrire sa taille, contour, et toute tendresse.

AORTE

- *L'examineur appuie fermement sur la partie supérieure de l'abdomen, légèrement à gauche de la ligne médiane.*

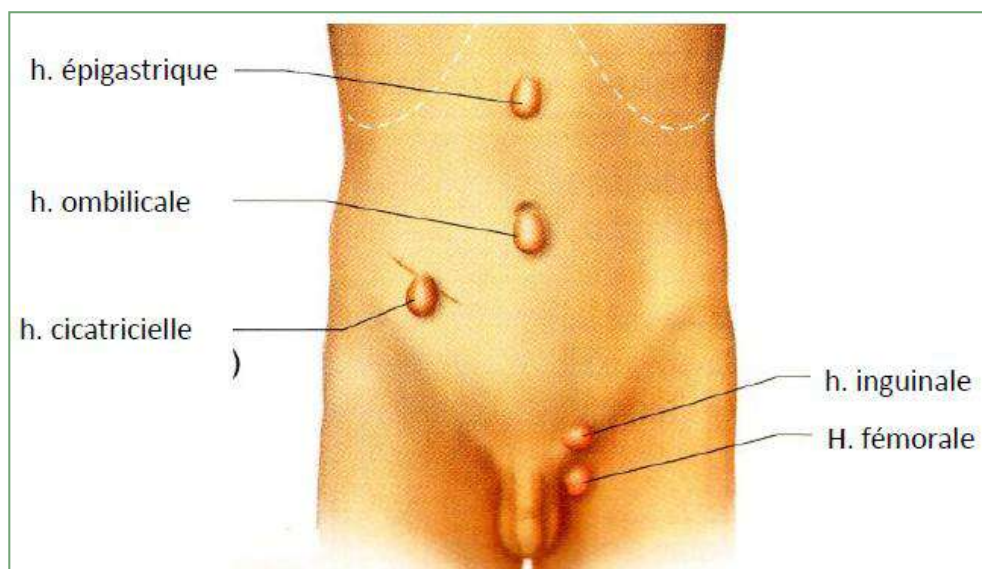


ORIFICES HERNIAIRES

Une hernie se définit par un trou, par un sac herniaire et par un contenu.

Il y a deux hernies fréquentes :

- Ombilicale :
 - Trou = nombril
 - Sac = péritoine
 - Contenu = graisse
 - *L'examineur place sa main sur le nombril.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Épigastrique :
 - Ce n'est pas une vraie hernie car elle ne possède pas de sac. L'hernie épigastrique est un trou dans la ligne blanche où un peu de graisse sort.
 - *L'examineur place sa main au niveau épigastrique.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Cicatricielle
 - Il faut chercher l'hernie chaque fois qu'il y a une cicatrice.
 - *L'examineur place sa main au niveau de la cicatrice.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*



INSPECTION ANALE

- Peau péri-anale et périnéale
- Sous-vêtement sales
- Fissure, marisque, thrombose péri-anales, abcès, selles
- Demander au patient de pousser et de fermer l'anus. <- Est-ce que la coordination est bonne?
- Toucher rectal:
 - L'examineur enfle un gant.
 - Le patient est couché en décubitus latéral.
 - Il dépose du gel sur la main et l'anus du patient.
 - Il introduit sa main gentiment et palpe gentiment.
 - L'examineur:
 - Recherche une masse
 - Recherche des selles dans l'ampoule rectale
 - Évalue la prostate
 - Évalue la longueur et la symétrie du sphincter anal.
- Localisation des lésions:

